阿尔茨海默病患者安宁疗护的特殊挑战与策略

吕亚茹　陈　凤　王　磊

【摘要】随着全球老龄化进程加速，阿尔茨海默病患者数量持续增长，其终末期的安宁疗护面临独特挑战。本文系统分析了我国阿尔茨海默病患者安宁疗护的现状，针对安宁疗护过程中存在的沟通障碍、家庭照护者负担以及营养与进食困难等问题，提出症状管理、预立医疗照护计划和法律政策的完善与推广应对策略，旨在提升患者生命质量，减轻照护负担，并为未来阿尔茨海默病患者安宁疗护的发展与实践提供参考依据。

【关键词】阿尔茨海默病　安宁疗护　沟通障碍　照顾者负担

Special Challenges and Strategies of Palliative Care for Alzheimer's Disease Patients

Lv Ya-ru, Chen Feng, Wang Lei

Abstract: Against the backdrop of accelerated global aging, the prevalence of dementia among elderly populations has witnessed a persistent upward trajectory, presenting distinctive challenges in end-of-life palliative care. This study conducts a systematic analysis of the current landscape of dementia palliative care in China, with particular emphasis on three critical dimensions: communication barriers, caregiver burden, and nutritional management difficulties. In response to these challenges, we propose a tripartite intervention framework encompassing optimized symptom management protocols, implementation of advance care planning, and refinement of legal policy frameworks. These evidence-based strategies aim to achieve dual objectives: enhancing quality of life for dementia patients while mitigating caregiver strain. The findings provide a substantive reference point for future policy formulation and clinical practice development in dementia palliative care.

Keywords: Alzheimer's disease; Palliative care; Communication barriers; Caregiver burden

阿尔茨海默病是一种不可逆的、进行性的神经退行性疾病，主要表现为记忆力减退、认知功能下降、行为和情绪改变[1]。随着病情的进展，严重影响患者的生活和社会能力。近年来，受人口老龄化进程不断加剧的影响，我国阿尔茨海默病患者的数量持续增长，给个人、家庭和社会带来严峻挑战，但目前仍缺乏特异性的诊治手段[2]。安宁疗护强调通过医疗和非医疗手段，提供身体、心理、社会和精神等多方面的综合性照护，以提高患者及其家属的生活质量，实现患者安详、有尊严地离世[3]。国外大量研究表明，安宁疗护作为一种以提高末期患者生活质量为目标的全方位服务，能够有效改善痴呆结局[4]。尤其是对于认知功能下降且可能出现激越行为的阿尔茨海默病患者而言，它的作用不仅限于症状管理，还包括心理、社会和精神层面的关照[5]。然而，由于阿尔茨海默病患者的特殊性，安宁疗护在实施过程中面临诸多挑战。

作者单位 / 朔州职业技术学院（吕亚茹）；山西白求恩医院（山西医学科学院）（陈凤）；山西医科大学（王磊）
基金项目 / 朔州职业技术学院山西省博士创新站

中国知网 https://www.cnki.net

我国阿尔茨海默病患者安宁疗护的现状

一、安宁疗护能够改善阿尔茨海默病患者激越行为

在阿尔茨海默病患者的安宁疗护实践中，激越行为是一个不容忽视的挑战。这种行为表现为患者的突然、无预警的身体或情绪爆发，可能包括身体攻击、自伤行为、不适当的言语或强烈的情绪反应。激越行为的出现与多种因素相关，如疾病的进展、药物副作用、患者的心理压力、照护者的压力以及患者的个人历史和文化背景等。在安宁疗护的背景下，理解和管理激越行为是提高患者生活质量的重要组成部分。多项研究表明[6-8]，安宁疗护可以显著减少阿尔茨海默病患者的激越行为，提高他们的治疗依从性。这包括但不限于个性化的症状管理、良好的沟通策略、环境的舒适度调整以及照护者的支持与培训等。

二、安宁疗护能够提升阿尔茨海默病患者生活质量

由于阿尔茨海默病的渐进性和不可逆性，随着时间的推移患者的生活质量往往急剧下降，部分阿尔茨海默病患者甚至存在自伤、他伤或攻击等异常精神行为，给照顾者带来额外的挑战。由于照顾者对阿尔茨海默病的认知度不高，其在日常生活中往往无法正确识别到阿尔茨海默病患者的需求，容易忽视疼痛、睡眠障碍等症状，甚至直接采用约束带对患者进行制动，给阿尔茨海默病患者的身心带来严重危害。研究证实，阿尔茨海默病患者的激越行为会对其日常生活自理能力及认知功能产生负面影响，进而导致其生活质量显著下降[9]。我国乔疏桐等[10]的 Meta 分析指出，安宁疗护能够调节阿尔茨海默病患者的焦虑、暴躁等负面情绪，减轻躁动行为，从而减少疾病给患者身心痛苦，提升患者幸福指数、满意指数和生活质量。

三、安宁疗护能够减轻阿尔茨海默病患者疼痛

研究数据显示，在阿尔茨海默病群体中，约 60% 的患者遭受疼痛困扰，约 40% 的患者因身体疼痛而显著受限了行动能力[11]。随着疾病进展至晚期，患者往往因认知功能衰退、语言表达障碍等一系列能力的丧失，而难以自主传达疼痛感受。再加上个体差异性的存在，使得医护人员及照顾者在疼痛的及时发现与准确识别上面临挑战。鉴于此，针对阿尔茨海默病症患者的疼痛管理策略已成为科研领域新的焦点议题，而如何有效减轻患者疼痛，既是当前面临的难题，也是亟待解决的关键问题。我国学者应翔等[8]通过随机对照试验表明，在阿尔茨海默病晚期采用安宁疗护是一种较好的选择，可有效改善患者认知障碍、生活质量及疼痛等。与 Elodie 等[12]的研究结果一致。

阿尔茨海默病患者安宁疗护的特殊挑战

一、认知能力下降导致的沟通困难

阿尔茨海默病患者在疾病晚期常出现严重的语言能力退化，甚至完全丧失表达能力，这使得安宁疗护中的沟通成为巨大挑战。由于患者无法准确描述疼痛、不适或情绪状态，医护人员和家属往往难以判断其真实需求。此外，痴呆患者的理解能力也大幅下降，难以配合医疗决策或表达个人意愿。即使患者早期曾签署预嘱，疾病进展后其意愿可能已无法准确传达，导致家属和医疗团队在决策时陷入困境。而家属的替代决策可能受到个人情感、文化观念或经济因素的影响，未必符合患者的最佳利益。为应对这一挑战，医护人员需依赖非语言沟通技巧，如观察患者的面部表情、肢体语言、声音变化等，并借助专业评估工具来识别潜在问题。同时，应在疾病早期阶段鼓励患者与家属进行预嘱讨论，明确医疗偏好，以减少后期的决策冲突。

二、家庭照顾者的压力与负担

阿尔茨海默病患者的照护往往持续多年，且随着病情恶化，照护强度不断增加，导致家庭照护者承受巨大的身心压力。许多照护者出现焦虑、抑郁、睡眠障碍甚至慢性疾病，但仍因社会期望或责任感而勉强支撑。在安宁疗护阶段，照护者可能面临更复杂的情感冲突，如“是否应放手”“是否算放弃治疗”等，这些心理负担可能影响决策质量。此外，社会支持体系的不足加剧了这一挑战。许多地区缺乏专业的居家安宁疗护

中国知网 https://www.cnki.net

服务，照护者不得不独自应对患者的精神行为症状、夜间躁动、大小便失禁等问题。此外，安宁疗护项目往往未纳入医保范围，经济压力也可能使家庭陷入困境。为缓解照护者负担，应提供心理支持、喘息照护等服务，并加强多学科团队的介入，帮助照顾者制订可持续的照护计划。

三、营养与进食困难的伦理困境

在阿尔茨海默病晚期，患者常出现吞咽困难，导致进食障碍、反复呛咳甚至吸入性肺炎。此时，是否采用人工营养成为极具争议的伦理问题。支持者认为人工营养可延长生命、避免饥饿，而反对者则认为其可能增加患者痛苦，且未必改善生存质量。研究表明，晚期痴呆患者使用人工营养并不能显著延长生存期或减少感染风险，反而可能增加褥疮、腹泻和躁动的风险[13]。此外，许多患者因无法理解鼻胃管的作用而试图拔管，导致需要物理约束，进一步降低尊严和舒适度。然而，家属可能因文化观念或情感因素坚持人工营养，而忽视患者的真实意愿。在安宁疗护中，应优先考虑患者的舒适度，如提供小口喂食、调整食物质地，而非默认采用侵入性营养支持。同时，医护人员需与家属充分沟通，帮助其理解疾病自然进程，并基于患者的最佳利益而非个人情感做出决策。

阿尔茨海默病患者安宁疗护策略的优化

一、全程与多维度症状管理

在阿尔茨海默病患者中，安宁疗护面临着特殊的挑战，包括认知能力下降导致的沟通困难、家庭照顾者的压力与负担以及营养与进食困难的伦理困境等。为了提高阿尔茨海默病患者的生活质量，安宁疗护实践中需要特别注意症状管理。在症状管理层面，阿尔茨海默病的照护需采取一种全程性、多维度的综合管理模式。尤其是对于阿尔茨海默病晚期的安宁疗护需要特别关注其独特的症状表现，包括沟通障碍导致的疼痛评估困难、吞咽功能减退引发的营养问题，以及运动功能丧失带来的多种并发症，这就要求建立专门针对阿尔茨海默病患者的症状评估工具和多学科协作的舒缓照护方案，整合神经科、姑息治疗科、康复科等多专业力量，采用药物与非药物干预相结合的方式，重点处理疼痛、呼吸困难、躁动等症状，同时注重口腔护理、皮肤护理等基础照护质量，最大限度地保障患者的舒适与尊严。

二、预立医疗照护计划的推进

预立医疗照护计划（advance care planning，ACP）在阿尔茨海默病管理中具有特殊的重要性和复杂性，因其核心是在患者决策能力丧失前，为其未来医疗照护做出符合自身价值观的规划。阿尔茨海默病的病程特性决定了 ACP 必须“早期启动”，在确诊后即由经过培训的医护人员以温和、多次的方式，引导患者与家人讨论疾病预后、可能的医疗情境并正式指定医疗代理人，确保即使在患者无法表达时，其意愿仍能得到尊重，避免无效且侵入性的治疗，保障生命末期的尊严[14]。这种计划允许患者或家属明确表达关于未来医疗护理的意愿和偏好，包括但不限于生命支持的级别、疼痛管理的偏好以及其他可能的医疗干预。阿尔茨海默病患者的 ACP 应当是一个持续的、动态调整的过程，随着病情的进展不断重新评估和确认之前的意愿，确保医疗决策符合患者的最大利益。美国一项研究发现，早期实施 ACP 的阿尔茨海默病患者，其住院率、医疗花销、死亡率均低于没有实施 ACP 的患者[15]。

三、法律政策的完善与推广

法律政策环境是保障安宁疗护实践可持续推广的基础支撑，当前我国在痴呆患者安宁疗护领域面临着多重政策挑战：缺乏专门针对安宁疗护的法律法规，预立医疗照护计划的法律效力不明确，长期照护保险对安宁疗护服务的覆盖不足，专业化安宁疗护服务体系建设滞后，以及专业人才培养机制不健全等。为应对这些挑战，需要采取系统性的政策应对策略：首先应推动国家层面安宁疗护相关立法，明确预立医疗照护计划的法律地位和执行规范；其次要完善医保支付政策，将阿尔茨海默病安宁疗护服务纳入长期护理保险支付范围，建

中国知网 https://www.cnki.net

立合理的服务定价和支付机制；同时需要加强服务体系建设，建立包括专科医院、社区安宁疗护机构和居家安宁疗护服务在内的多层次服务网络，制定阿尔茨海默病安宁疗护服务标准和质量评价体系；最后需要开展公众教育，提高社会对安宁疗护和预立医疗照护计划的认知和接受度。

四、构建跨学科协作体系

跨学科协作体系的首要任务是构建一个结构化的核心团队。该团队应涵盖医学、心理学、社会学及法学等关键领域的专业人员。团队成员需超越学科界限，确立共同的安宁疗护目标和价值观。定期的跨学科病例讨论会是核心平台，在实践中表现为从“独立干预”到“组合拳”式的综合应对。例如，在处理患者“躁动”症状时，医学判断其是否源于疼痛或感染；心理学解读其行为背后的心理需求与沟通障碍；社会学则评估照护环境与家庭互动的影响。最终干预方案是医学调整用药、心理学提供安抚策略、社会学引入喘息服务的有机结合。在推进 ACP 时，合力更为显著：医学提供预后信息，法学确保程序合规，心理学疏导决策情感冲突，使医疗决策既符合患者意愿，又得到法律保障与情感支持。

小结与展望

当前，安宁疗护在阿尔茨海默病患者中的应用仍处于发展阶段，其实施现状受限于多种因素，如医疗体系的不成熟、专业人员的缺乏以及公众对安宁疗护认知度不足等。这些挑战不仅影响了安宁疗护服务的提供，也限制了其在提高患者生活质量方面的潜力。未来，期望通过优化症状管理措施、推进预立医疗照护计划和完善相关法律政策等，可以进一步提升安宁疗护的质量和可及性，确保每一位需要的阿尔茨海默病患者都能获得适宜、优质的安宁疗护服务。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献

[1] Fukui T. Historical review of academic concepts of dementia in the world and Japan:with a short history of representative diseases[J].Neurocase,2014,21(3):369-376.

[2] Montgomery W, Goren A, Kahle-Wrobleski K, et al. Detection, diagnosis, and treatment of alzheimer’s disease dementia stratified by severity as reported by caregivers in Japan[J]. Neuropsychiatr Dis Treat, 2018(14): 1843-1854.

[3] Hanson LC, Kistler CE, Lavin K, et al. Triggered palliative care for late-stage dementia: a pilot randomized trial[J]. J Pain Symptom Manage, 2019, 57(1): 10-19.

[4] Singer AE, Goebel JR, Kim YS, et al. Populations and interventions for palliative and end-of-life care: a systematic review[J]. J Palliat Med, 2016, 19(9): 995-1008.

[5] Sampson EL, Ritchie CW, Lai R, et al. A systematic review of the scientific evidence for the efficacy of a palliative care approach in advanced dementia[J]. Int Psychogeriatr, 2005, 17(1): 31-40.

[6] Chenoweth L, King MT, Jeon YH, et al. Caring for aged dementia care resident study (CADRES) of person-centred care, dementia-care mapping, and usual care in dementia: a cluster-randomised trial[J]. Lancet Neurol, 2009, 8(4): 317-325.

[7] 许洁 . 安宁疗护对阿尔茨海默病激越行为以及康复治疗依从性的影响 [J]. 东方药膳 , 2021(5): 266.

[8] 应翔 , 刘晓波 , 汪群芳 , 等 . 安宁疗护干预阿尔茨海默病晚期患者的效果观察 [J]. 中国乡村医药 , 2019, 26(20): 69-70.

[9] Hunt LJ, Covinsky KE, Yaffe K, et al. Pain in community-dwelling older adults with dementia: results from the national health and aging trends study[J]. J Am Geriatr Soc, 2015, 63(8): 1503-1511.

[10] 乔疏桐 , 占婷婷 , 胡晓涵 , 等 . 安宁疗护对阿尔茨海默病患者干预效果的 Meta 分析 [J]. 护理学 , 2022, 11(5): 700-709.

（下转第 68 页）

中国知网 https://www.cnki.net

动的体现。

医者不仅是人还是“完人”，不仅关注“人的病”，更要关注“病的人”。了解患者的家庭、工作、心理状态，提供身心社灵全方位的支持，这才是“全心全意为病人服务”的深意。

医者于压力中守初心，做“有韧性”的生命守护者。自我关怀与价值认同：医务工作者自身也是人，也会疲惫、委屈。李文启示我们，要从守护生命的意义感中汲取力量。认识到每一次成功的救治、每一次痛苦的缓解，都是在践行一项崇高的事业，这种价值认同是抵御职业倦怠的最好良药。

医者不是单独施爱的天使，应该具有团队人文建设。医院管理层应积极营造充满人文关怀的科室文化，鼓励同事间的支持与理解，建立有效的心理疏导机制。让医务工作者首先在一个被尊重的环境中工作，他们才能更好地将尊重传递给患者。

于制度中显情怀，做“有担当”的体系建设者。倡导人性化流程，在参与医院管理、优化服务流程时，始终以患者体验为中心，思考如何让流程更便捷、更舒适、更富有人情味。例如，简化繁琐的手续，提供清晰的指引，设置温馨的候诊区等。

传承与带教：资深医者应将医学人文精神作为核心内容，言传身教给年轻医生和医学生。让敬畏生命、尊重病患成为一代代医务工作者薪火相传的“基因”。

全心全意为病人服务的现实意义

在健康中国战略和深化医改的背景下，“全心全意为病人服务”具有极其紧迫的现实意义。

李文的现实指导意义在于他是一把构建和谐医患关系的“金钥匙”。所有的矛盾，最终都需要靠信任来化解。而信任，正源于患者真切感受到医者全心全意的付出。这种服务不是卑微的伺候，而是基于专业与仁爱的主动担当。

它是提升医疗服务质量“软实力”的核心。先进的设备和技术是“硬实力”，而人文关怀则是无可替代的“软实力”。当服务充满人性温度时，医疗的整体效能和患者满意度会得到质的提升。

它是实现“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变的必然要求。健康中国强调大健康观念，意味着医学的疆域在不断拓宽。医务工作者不仅要会治病，更要成为人民健康的守护者、倡导者。这更需要一种发自内心的、全心全意为人民健康服务的精神。

《敬畏生命与尊严》一文，以其深刻的思想性和强烈的人文关怀，为我们这个时代的医学事业注入了一剂清醒剂。它告诉我们，无论科技如何进步，制度如何变革，医学永远不能失去其人性的灵魂。引导广大医务工作者重拾这份敬畏与尊严，不仅是解决当下现实困境的出路，更是推动中国卫生事业健康发展，真正践行“为人民服务”根本宗旨的百年大计。

（上接第 53 页）

[11] Timmons S, Fox S. Palliative care for people with dementia[J]. Handb Clin Neurol, 2023(191): 81-105.

[12] Achterberg WP, Pieper MJC, van Dalen-Kok AH, et al. Pain management in patients with dementia[J]. Clin Interv Aging, 2013(8): 1471-1482.

[13] 许晨，魏继鸿，陈蓓. 阿尔茨海默病患者吞咽功能全程管理方案的应用研究 [J]. 军事护理 ,2023,40(5):49-53.

[14] Committee on Approaching Death: Addressing Key End of Life Issues, Institute of Medicine. Dying in america: improving quality and honoring individual preferences near the end of life[M]. Washington (DC): National Academies Press (US), 2015:25.

[15] Nicholas LH, Bynum JPW, Iwashyna TJ, et al. Advance directives and nursing home stays associated with less aggressive end-of-life care for patients with severe dementia[J]. Health Aff (Millwood), 2014, 33(4): 667-674.

中国知网 https://www.cnki.net